Compréhension de texte **Serie 3-2025**

18 Questions - 45 Minutes

Texte pour les questions 1) à 6)

Le pharynx, un tube musculaire de 12 à 15 cm de long, s'étend de l'os occipital à la 6ème vertèbre cervicale. Il se divise en trois parties : l'épipharynx, le mésopharynx et l'hypopharynx. L'épipharynx est situé en face des fosses nasales et est relié à celles-ci par les choanes. Il s'étend de la base du crâne jusqu'au palais mou et contient la trompe d'Eustache. Celle-ci présente un renflement, le torus tubaire, et peut être ouverte par le muscle salpingo-pharyngien, le muscle tenseur du voile du palais et le muscle releveur du voile du palais, ce qui permet l'équilibrage de la pression et la ventilation de l'oreille moyenne. Les deux muscles du voile du palais forment un triangle, le releveur représentant l'hypoténuse et le tenseur représentant les côtés adjacents et opposés. Le tenseur s'enroule autour de l'hamulus ptérygoïdien (pommette ptérygoïdienne). Le mésopharynx est relié à la cavité buccale par l'isthme du gosier, délimité par l'arc palato-pharyngien et l'arc palato-glosse. Il s'étend du palais mou à l'épiglotte et comprend également les vallécules épiglottiques, des creux situés à côté de l'épiglotte. La partie inférieure, l'hypopharynx, est reliée au larynx par l'Aditus laryngé et abrite le récessus piriforme, par lequel les aliments parviennent dans l'œsophage. L'œsophage représente la transition caudale du pharynx. Le rameau interne du nerf laryngé supérieur passe directement sous sa muqueuse.

La paroi du pharynx est formée de trois muscles, tous innervés par le nerf glossopharyngien (IX) et le nerf vague (X) via le plexus pharyngé, ainsi que par la membrane pharyngo-basilaire. De haut en bas, on trouve : le muscle constricteur supérieur du pharynx, le muscle constricteur moyen du pharynx et le muscle constricteur inférieur du pharynx. Ce dernier s'étend jusqu'au larynx et présente souvent un triangle musculaire faible, le triangle de Killian. Les trois muscles pharyngés appariés, qui se chevauchent comme des tuiles, se rejoignent dorsalement dans le raphé pharyngé.

D'autres muscles servent à soulever le pharynx lors de la déglutition : le muscle stylo-pharyngien prend naissance au niveau du processus styloïde et s'étend entre le muscle constricteur supérieur et moyen du pharynx jusqu'à la paroi latérale du pharynx. Il est innervé par le nerf glossopharyngien (IX). Le muscle palato-pharyngien s'étend du palais mou à la paroi latérale du pharynx et au cartilage thyroïdien. Le muscle salpingo-pharyngien est un muscle fin qui s'étend du bord libre du cartilage tubaire à la paroi latérale du pharynx. Au début de l'œsophage, entre la musculature annulaire et la musculature longitudinale s'étendant latéralement, se trouve le triangle de Laimer. Le pharynx est séparé dorsalement de la musculature prévertébrale (muscle long du cou et de la tête) et de la colonne vertébrale par l'espace rétropharyngé. L'espace rétropharyngé se prolonge distalement dans l'espace rétro-œsophagien et se termine au niveau du diaphragme. Sur le côté du pharynx se trouve l'espace latéro-pharyngé, dans lequel passent les nerfs crâniens IX, X, XI, XII ainsi que la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne.

L’ espace latéro-pharyngien est divisé par le diaphragme styloïdien en un espace préstyloïde et un espace rétro-styloïde. Le préstyloïde contient les artères palatines ascendante et descendante, tandis que le rétro-styloïde contient les vaisseaux et les nerfs qui quittent la base du crâne par les ouvertures suivantes : le canal hypoglosse (pour le nerf hypoglosse - XII), le foramen jugulaire (pour le nerf glossopharyngien - IX, le nerf vague - X, nerf accessoire - XI, veine jugulaire interne), le canal carotidien

CC BY NC 1nc-wiki.ch

(pour l'artère carotide interne) ainsi que d'autres structures telles que le tronc sympathique, l'artère occipitale (issue de l'artère carotide externe, passe derrière le ventre postérieur du muscle digastrique vers le côté de l'os occipital) et les branches terminales de l'artère pharyngée ascendante (également issue de l'artère carotide externe, passe vers l'intérieur en direction du pharynx).

Le nerf hypoglosse passe dorsalement au niveau du nerf vague et traverse le triangle carotidien entre le muscle hyo-glosse et le muscle mylo-hyoïdien. Il innerve généralement les muscles de la langue de manière somatomotrice avec des fibres provenant du noyau du nerf hypoglosse : muscle stylo-glosse, muscle génioglosse et muscle hyoglosse. Sur le plan clinique, il est important de noter qu'en cas de trouble de l'innervation, la langue dévie vers le côté atteint. De plus, les fibres de l'anse cervicale profonde (racine supérieur) s'attachent au nerf hypoglosse et l'accompagnent brièvement avant de se ramifier et d'innerver soit directement le muscle génio-hyoïdien et le muscle thyro-hyoïdien, soit indirectement, via l'anse cervicale profonde, le reste de la musculature infra-hyoïdienne (muscle omo-hyoïdien, muscle sterno-hyoïdien, muscle sterno-thyroïdien).

1) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut être** déduite du texte ?

(A) Le nerf glossopharyngien se dirige vers la paroi latérale du pharynx avec son muscle conducteur, le muscle stylopharyngien
(B) Le muscle tenseur du voile du palais s'enroule autour de l'hamulus ptérygoïdien et ouvre la trompe auditive avec deux autres muscles.
(C) Le muscle constricteur inférieur du pharynx peut entourer le triangle de Killian, une zone de faiblesse musculaire dans la région de l'hypopharynx.
(D) Le nerf laryngé supérieur passe directement sous la muqueuse du mésopharynx.
(E) Les trois muscles du pharynx se chevauchent comme des tuiles et s'insèrent dorsalement au niveau du raphé pharyngien.

CC BY NC 2nc-wiki.ch

2) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

I. Le récessus piriforme fait partie de l'hypopharynx et achemine les aliments vers l'œsophage.
II. Le muscle stylo pharyngien est innervé par le nerf vague.
III. Les vallécules épiglottiques se trouvent dans le mésopharynx.
IV. L'artère palatine descendante se trouve dans l'espace préstyloïde.

(A) Seulement I et II
(B) Seulement II et IV
(C) Seulement I, II et III
(D) Seulement I, III et IV
(E) Les quatre affirmations

3) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut être** déduite du texte ?

(A) L'épipharynx s'étend de la base du crâne jusqu'au palais mou et communique avec la cavité nasale par les choanes.
(B) Le muscle stylo pharyngien traverse le triangle de Laimer pour atteindre la paroi latérale du pharynx.
(C) L'isthme du gosier est délimité par l'arc palatoglossus et l'arc palato pharyngien.
(D) Le muscle salpingo-pharyngien prend naissance au niveau du cartilage tubaire et s'étend jusqu'à la paroi latérale du pharynx.
(E) L'hypopharynx est relié au larynx par l'aditus laryngé.

4) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Les trois étages du pharynx se distinguent tant par leur emplacement que par leurs connexions avec les organes voisins.
II. Le plexus pharyngé est exclusivement constitué de fibres du nerf vague.
III. L'espace rétro-œsophagien se prolonge caudalement par l'espace rétropharyngé.
IV. Le nerf hypoglosse passe entre deux muscles de la langue à travers le triangle carotidien.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
(E) Les quatre affirmations peuvent être déduites.

3nc-wiki.ch

5) Quelles affirmations **ne peuvent être** déduites du texte ?

I. Le canal carotidien se trouve dans l'espace rétro-styloïde.
II. L'artère pharyngée ascendante s'étend en direction du pharynx.
III. Le tronc sympathique passe dans l'espace rétro-styloïde.
IV. Le nerf vague passe en avant du nerf hypoglosse.

(A) Seulement IV.
(B) Seulement II et IV.
(C) Seulement I et II.
(D) Seulement I, III et IV.
(E) Les quatre affirmations.

6) Quelles conclusions peut-on tirer du texte ?

I. La musculature infra hyoïdienne peut être influencée indirectement par le nerf hypoglosse via les fibres de l'ansa cervicalis profunda.
II. Le muscle hyoglosse est situé en position médiale par rapport au muscle mylo-hyoïdien.
III. En cas de défaillance du nerf hypoglosse, la langue dévie vers le côté affecté.
IV. La racine supérieure de l'ansa cervicalis profunda se fixe temporairement au nerf hypoglosse.

(A) Seulement I et II.
(B) Seulement II et IV.
(C) Seulement I, II et III.
(D) Seulement I, III et IV.
(E) Les quatre affirmations.

4nc-wiki.ch

Réponses:

1. D
2. D
3. B
4. A
5. A
6. D

5nc-wiki.ch

Compréhension de texte **Serie X-20XY**

18 Questions - 45 Minutes

Texte pour les questions 7) à 12)

Toutes les cellules du corps humain contiennent exactement le même ADN, mais leurs fonctions diffèrent considérablement. Le processus de différenciation cellulaire donne aux cellules leurs propriétés structurelles, morphologiques et fonctionnelles spécifiques. Les facteurs extrinsèques qui influencent ce processus sont les hormones, les facteurs de croissance, les facteurs de différenciation et les interactions cellulaires. Sous l'influence de facteurs de transcription spécifiques au type cellulaire (« facteurs intrinsèques »), des modifications de l'expression génomique se produisent également. De plus, des modifications épigénétiques permettent de maintenir l'état activé ou réprimé d'un gène pendant les divisions cellulaires et les phases de différenciation. Une modification épigénétique décrit le changement structurel des régions de la chromatine qui permettent la détection, le marquage ou le maintien d'états modifiés de l'activité génétique. Concrètement, cela signifie que toutes les cellules contiennent en principe l'intégralité de l'ADN, mais que des facteurs intrinsèques et des modifications épigénétiques permettent une lecture différenciée du génome. Dans les cellules, de nombreuses protéines sont liées au brin d'ADN. Ce complexe ADN-protéine est appelé chromatine. Les protéines histones, autour desquelles s'enroule le brin d'ADN, sont particulièrement nombreuses. Le degré de condensation de la chromatine peut varier d'une cellule à l'autre. Les régions dans lesquelles la chromatine est fortement condensée sont généralement inactives en termes de transcription. Les gènes qu'elles contiennent ne peuvent donc pas être lus. On parle alors d'hétérochromatine. L'euchromatine, en revanche, désigne la chromatine qui est peu condensée. Cet état lâche permet la liaison de facteurs de transcription aux régions promotrices de l'ADN. La liaison des facteurs de transcription à la région promotrice d'un gène active sa transcription. Ces états variables de condensation de la chromatine dépendent fortement des modifications épigénétiques de l'ADN ou des protéines histones. La séquence d'ADN reste toutefois toujours inchangée et les modifications épigénétiques sont en principe réversibles. Les protéines histones sont soumises à quatre types différents de modifications épigénétiques : l'acétylation, la méthylation, la phosphorylation et l'ubiquitination. Lors de l'acétylation, un groupe acétyle est lié à l'histone par l'intermédiaire de la HAT (histone acétyltransférase), ce qui entraîne un relâchement de la chromatine. Le groupe acétyle peut être à nouveau éliminé par l'intermédiaire d'un HDAC (histone désacétylase). Une modification épigénétique importante de l'ADN est l'ajout de groupes méthyles à la cytosine qui précède une guanine. Ces cytosines spécifiques sont abrégées CpG. Les régions promotrices contiennent souvent un nombre particulièrement élevé de CpG, c'est pourquoi on parle également d'îlots CpG. La méthylation des CpG dans les régions promotrices entraîne la liaison de complexes protéiques spécifiques (MPBs) qui inhibent l'action des facteurs de transcription et empêchent ainsi la transcription des gènes suivants. De plus, les MPBs recrutent des HDACs, ce qui entraîne la désacétylation des histones. L'activité transcriptionnelle est ainsi fortement réduite dans les régions d'ADN hyper-méthylées.

L'empreinte parentale est un phénomène résultant de la méthylation de l'ADN. Dans les cellules, la grande majorité des gènes sont exprimés à la fois par les copies paternelles et maternelles (allèles). Dans le cas des gènes dits « imprimés », seul l'un des deux allèles est exprimé. Cela s'explique par la

CC BY NC 6nc-wiki.ch

méthylation différente des allèles parentaux. Le gène réprimé est ainsi hyperméthylé, tandis que l'autre est hypométhylé. Cette méthylation de l'ADN est très stable et se maintient même lors de la division cellulaire. Des anomalies dans l'expression de ces gènes imprimés peuvent entraîner des pathologies du développement ou des cancers. On peut citer comme exemples les syndromes de Beckwith-Wiedemann et de Silver-Russell, qui résultent d'anomalies épigénétiques dans la même région chromosomique 11p15. Cette région chromosomique 11p15 contient deux gènes : Igf2 et H19. Igf2 code pour une protéine qui favorise la croissance et H19 pour un ARN non codant ayant une fonction anti-prolifération. Entre ces deux gènes se trouve un îlot CpG. Dans l'allèle maternel, l'îlot CpG est hypo-méthylée. Cela permet la liaison du complexe CTCF, qui rend possible la transcription du gène H19 et désactive le gène Igf2. Dans l'allèle paternel, l'îlot CpG est hyperméthylé et le CTCF ne peut pas se lier. Le gène H19 est alors inactivé et le gène Igf2 est transcrit. Dans le syndrome de Beckwith-Wiedemann, l'îlot CPG est hyperméthylé sur les deux allèles. Les deux copies du gène Igf2 sont alors exprimées et le gène H19 est complètement inactivé. Il en résulte une croissance excessive. Dans le syndrome de Silver-Russell, en revanche, l'îlot CpG est inactif sur les deux allèles, ce qui entraîne un retard de croissance.

7) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut être** déduite du texte ?

(A) Toutes les cellules du corps humain contiennent les mêmes informations génétiques.
(B) La différenciation des cellules dépend des hormones.
(C) Les modifications épigénétiques sont perdues lors de la division cellulaire.
(D) Les gènes peuvent être activés ou réprimés.
(E) La transcription d'un gène est régulée par des régions promotrices.

7nc-wiki.ch

8) Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

I. La méthylation de l'ADN diffère chez les parents.
II. L'allèle réprimé est hypométhylé.
III. Les gènes imprimés entraînent des pathologies du développement.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I. est correcte.
(C) Seule l'affirmation III. est correcte.
(D) Les affirmations II. et III. sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

9) Laquelle des affirmations suivantes concernant la méthylation de l'ADN est correcte ?

(A) Un groupe méthyle est ajouté à une guanosine.
(B) La méthylation de l'ADN a un effet indirect sur la méthylation des histones.
(C) L'activité transcriptionnelle est élevée dans les régions hyper-méthylées.
(D) La méthylation de l'ADN est réversible.
(E) Les CpG sont toujours méthylés.

10) Laquelle des affirmations suivantes concernant le syndrome de Beckwith-Wiedemann est **fausse** ?
Dans le syndrome de Beckwith-Wiedemann…

(A) Il y a une croissance excessive.
(B) Le CTCF peut se lier aux deux allèles.
(C) Le gène Igf2 est transcrit sur les deux allèles.
(D) L'îlot CpG est hyperméthylé.
(E) Il s'agit d'un défaut d'empreinte parentale.

CC BY NC

11) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

I. L'enzyme HAT participe à l'acétylation des histones.
II. HDAC participe à la méthylation de l'ADN.
III. Les histones font partie de la chromatine.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I. est correcte.
(C) Seule l'affirmation II. est correcte.
(D) Les affirmations I. et III. sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

12) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Un défaut épigénétique dans la région chromosomique 11p15 entraîne toujours un retard de croissance.
II. Le gène maternel Igf2 est activé dans des circonstances normales.
III. Pour la majorité des gènes, seule une copie du gène (maternel ou paternel) est transcrite de manière active.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I. est correcte.
(C) Seule l'affirmation II. est correcte.
(D) Les affirmations I. et III. sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

Réponses:

7. C
8. B
9. D
10. B
11. D
12. E

10nc-wiki.ch

Compréhension de texte **Serie X-20XY**

18 Questions - 45 Minutes

Texte pour les questions 13) à 18)

L'oreille moyenne est composée de la trompe auditive, des cellules mastoïdiennes et de la cavité tympanique (cavitas tympani). La cavité tympanique contient les trois osselets : le marteau, l'enclume et l'étrier. La cavité tympanique peut être divisée topographiquement en épitympanum (au-dessus de la membrane tympanique, le tympan), mésotympanum (parallèle au tympan) et hypotympanum. Les osselets, qui sont reliés entre eux, amplifient le signal du tympan de 17 fois. La tête du marteau et de l'enclume sont reliées entre elles par une articulation en selle (amphiarthrose), l'articulation incudo-malléaire. Le manche du marteau repose sur le tympan. Au total, le marteau dispose de trois ligaments : le ligament antérieur du marteau, le ligament supérieur du marteau (au niveau du haut) et le ligament latéral du marteau (au niveau de la paroi latérale). La tête de l'enclume s'articule avec le marteau. L'enclume possède deux branches s'étendant vers le bas, la branche longue de l'incus et la branche courte de l'incus, la branche longue se transformant en processus lenticulaire et s'articulant avec l'étrier dans l'articulation incudo-stapédienne, une articulation sphérique plate. L'enclume possède deux ligaments : le ligament postérieur de l'enclume (de la branche longue de l'incus à la paroi latérale) et le ligament supérieur de l'enclume (au niveau haut). La tête de l'étrier s'articule avec l'enclume. L'étrier est prolongé par un pied antérieur et un pied postérieur qui convergent vers la base de l'étrier. La base de l'étrier est reliée à la fenêtre vestibulaire par le ligament annulaire de l'étrier, qui est mobile. Toutes les structures de l'oreille moyenne sont recouvertes d'une couche muqueuse.

La cavité tympanique, légèrement inclinée, présente six parois : la paroi latérale (paries membranaceus) est principalement formée par le tympan. Le muscle tenseur du tympan, qui prend naissance dans la partie verticale du canal facial à partir du nerf facial, s'insère ici au niveau du manche du marteau. Il s'étend dans un pli muqueux, le pli malléaire postérieur, accompagné de l'artère tympanique postérieure, entre le marteau et l'enclume à travers la cavité tympanique vers le côté et le long du pli malléaire antérieur jusqu'à la fissure pétro-tympanique. La paroi médiale (paries labyrinthicus) est adjacente à l'oreille interne et est en grande partie délimitée par le promontoire, formé par la cochlée. Le plexus tympanique se trouve sur le promontoire. Il est constitué du nerf tympanique (une branche du 9ème nerf crânien, le nerf glossopharyngien, avec des fibres provenant du noyau salivaire inférieur). Ces fibres se prolongent à travers le hiatus du canal du nerf petit pétreux sous forme de nerf pétreux mineur et passent par la fissure sphéno-pétrosienne en direction du ganglion otique, où les fibres parasympathiques sont commutées. Le nerf suit ensuite le nerf auriculotemporal du nerf maxillaire jusqu'à la parotide, qu'il innerve également.

Au-dessus du promontoire se trouve la fenêtre vestibulaire, fermée par la base de l'étrier. Sur le côté, la partie horizontale du canal du nerf facial (proéminence du canal facial) dans laquelle passe le nerf facial fait saillie. Plus haut, le conduit semi-circulaire latéral s'incurve dans la paroi et forme la proéminence du canal semi-circulaire latéral. Dans la partie postérieure inférieure de la paroi médiale se trouve la fenêtre cochléaire en forme de rein, qui est fermée par la membrane tympanique secondaire et sert à équilibrer la pression entre l'oreille interne remplie de liquide et l'oreille moyenne remplie d'air. Devant la fenêtre vestibulaire se trouve le processus cochléariforme, autour duquel le tendon du muscle tenseur du tympan (innervé par le nerf mandibulaire) s'incurve vers le côté. Derrière le sinus tympanique, on aperçoit

CC BY NC 11nc-wiki.ch

l'éminence pyramidale, à la surface antérieure de laquelle le tendon du muscle stapédien sort et se dirige vers la tête de l'étrier. Ces deux muscles servent de réflexes protecteurs pour atténuer les bruits forts.

La paroi supérieure (paries tegmentalis) est constituée d'une fine plaque osseuse, le tegmen tympani, qui sépare la cavité tympanique de la fosse crânienne moyenne. La paroi inférieure (paries jugularis) est adjacente au bulbe supérieur de la veine jugulaire interne, le point le plus profond de la cavité tympanique. C'est là que le nerf tympanique pénètre dans la cavité tympanique avec l'artère tympanique inférieure par le canal tympanique. La paroi antérieure (paries caroticus) est adjacente au canal carotidien et contient l'ouverture de la trompe auditive ainsi que l'entrée du muscle tenseur du tympan. C'est là que débouche le canal musculo-tubaire, qui est divisé par une fine lamelle osseuse en le semi-canal de la trompe auditive, dans lequel se trouve la trompe auditive avec l'orifice tympanique de la trompe, et le semi-canal du muscle tenseur du tympan, dans lequel se trouve le muscle tenseur du tympan. La paroi postérieure (paries mastoideus) passe par l'antre mastoïdien pour rejoindre les cellules mastoïdiennes.

13) Quelle affirmation **ne peut être** déduite du texte ?

(A) La trompe d'Eustache relie la cavité tympanique au nasopharynx et sert à équilibrer la pression.
(B) L'articulation incudo-stapédienne est une articulation sphérique plate située entre l'enclume et l'étrier.
(C) Le nerf tympanique provient du nerf glossopharyngien et forme le plexus tympanique.
(D) Le nerf facial innerve le muscle tenseur du tympan.
(E) La paroi latérale de la cavité tympanique est principalement constituée de la membrane tympanique.

CC BY NC

14) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles **ne peuvent être** déduites du texte ?

I. La cavité tympanique est tapissée d'une muqueuse et est adjacente à l'oreille interne.
II. La fenêtre cochléaire est fermée par la membrane tympanique secondaire et permet l'équilibrage de la pression.
III. Le muscle stapédien s'insère sur le manche du marteau et régule la transmission du son.
IV. La base de l'étrier est reliée à la fenêtre vestibulaire par le ligament annulaire stapédien.

(A) Seule l'affirmation I ne peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation III ne peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I, II et III ne peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations III et IV ne peuvent être déduites.
(E) Les quatre affirmations ne peuvent être déduites.

15) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Le plexus tympanique se trouve sur le promontoire et se prolonge sous la forme du nerf pétreux mineur.
II. Le nerf facial innerve la muqueuse de la cavité tympanique.
III. Certaines parties du muscle tenseur du tympan s'enroulent autour du processus cochléariforme.
IV. La cavité tympanique est adjacente à l'oreille interne par sa paroi médiale.

(A) Seulement I et II
(B) Seulement II et IV
(C) Seulement I, III et IV
(D) Les quatre affirmations
(E) Aucune des affirmations

16) Selon le texte, laquelle des affirmations suivantes est **fausse** ?

(A) Le nerf pétreux mineur conduit les fibres parasympathiques vers le ganglion otique.
(B) Le nerf tympanique contient exclusivement des fibres sensorielles.
(C) Le nerf facial passe dans un canal osseux le long de la paroi médiale de la cavité tympanique.
(D) Le promontoire est formé par les spires de la cochlée.
(E) L'artère tympanique postérieure passe à travers la cavité tympanique.

CC BY NC

17) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Le nerf facial passe dans le canal facial au-dessus de la fenêtre vestibulaire et de la fenêtre cochléaire.
II. L'artère tympanique inférieure pénètre dans la cavité tympanique par la fissure pétro-tympanique.
III. La cavité tympanique est adjacente au bulbe supérieur de la veine jugulaire interne.
IV. Le muscle tenseur du tympan est innervé par une branche du nerf mandibulaire.

(A) Seulement I. et II.
(B) Seulement II. et IV.
(C) Seulement I., III. et IV.
(D) Seulement I., II. et III.
(E) Les quatre affirmations

18) Parmi les conséquences suivantes, laquelle est la plus probable en cas de fracture de la fissure pétro-tympanique ?

(A) Une atteinte de l'artère tympanique postérieure qui traverse la cavité tympanique.
(B) Une lésion de l'éminence pyramidale avec paralysie du muscle stapédien.
(C) Une lésion du nerf tympanique avec perturbation du plexus tympanique.
(D) Un blocage de la fenêtre vestibulaire par dislocation de l'étrier.
(E) Une hémorragie dans le canal facial avec paralysie faciale complète.

CC BY NC

Réponses:

13. A
14. D
15. C
16. B
17. C
18. A

15nc-wiki.ch